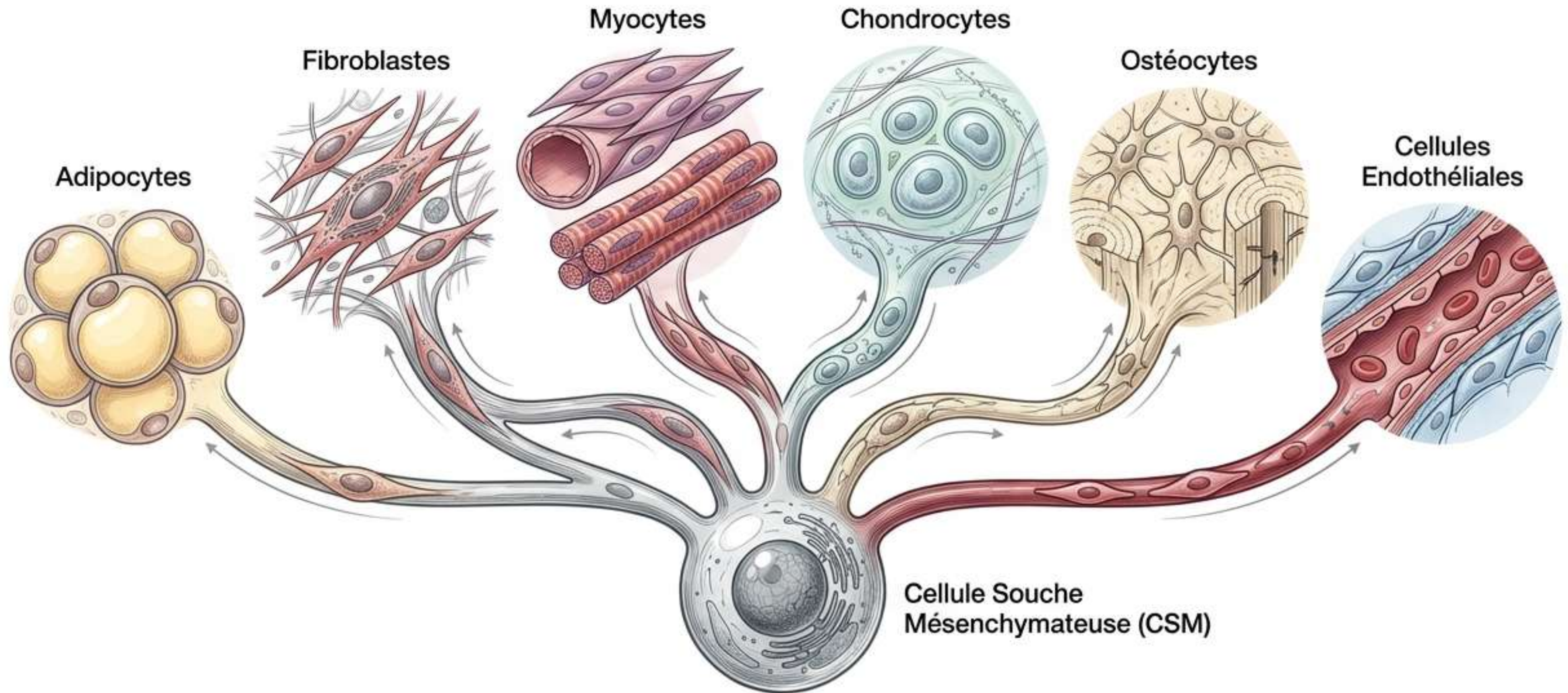
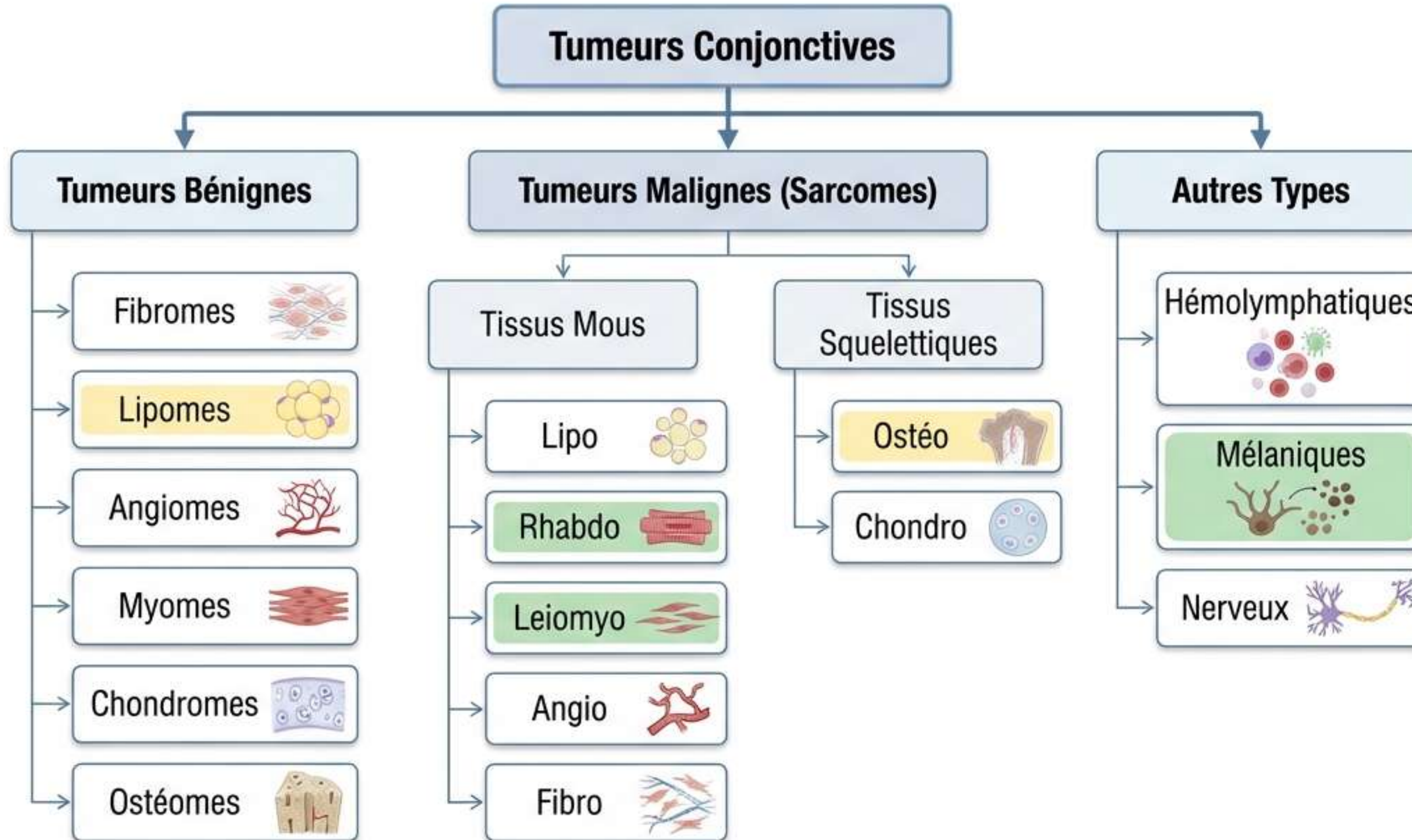


TUMEURS DES TISSUS CONJONCTIFS

Guide d'Étude & Synthèse pour Examens



Plan du Cours & Stratégie



STRATÉGIE D'EXAMEN

Règle d'Or : La classification est basée sur le type de tissu reproduit par la tumeur [Ref: OMS 2020].

Légende :

 **Surligné Jaune :** Question d'examen précédente.

 **Surligné Vert :** Concept clé ou haute probabilité.

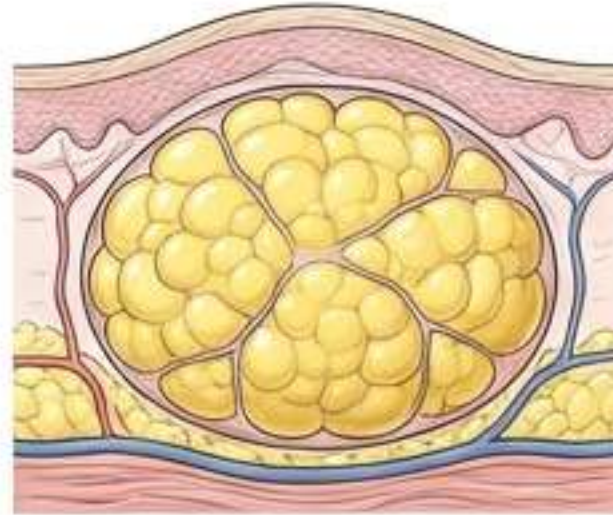
1. Tumeurs Bénignes : Fibreux, Adipeux, Vasculaire

A/ Les Fibromes



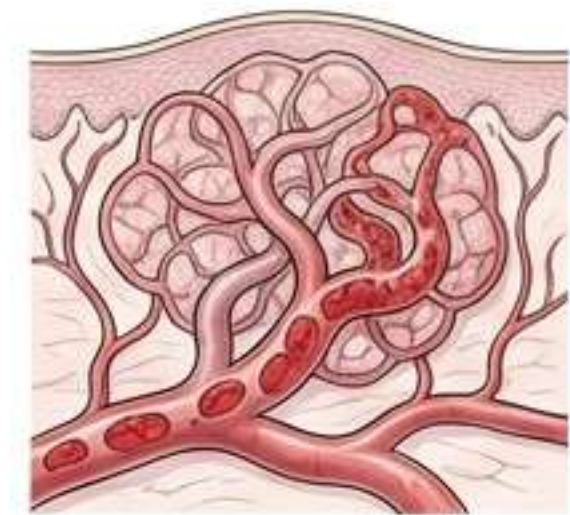
- Lésions nodulaires, bien circonscrites.
- Sièges : derme, chorion des muqueuses ou parenchymes.
- Constitution : tissu conjonctif adulte, riche en collagène [Ref : Q2].

B/ Les Lipomes



- Tumeur bénigne du tissu adipeux [Ref : Q4].
- Généralement encapsulées, uniques ou multiples.
- Constitution : cellules adipeuses matures groupées en lobules.
- Variantes : fibrolipome, angiolipome.
- Siège habituel : tissu sous-cutané.

C/ Les Angiomes

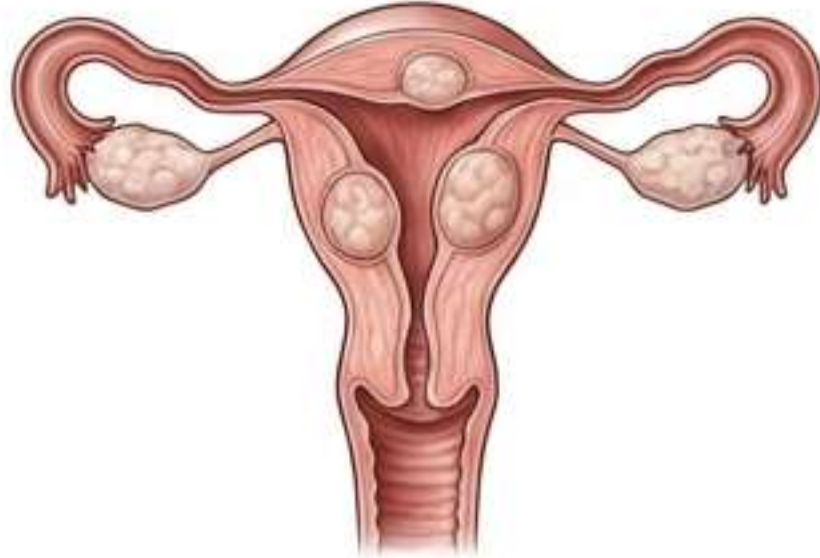


- Les angiomes ou les lymphangiomes sont le plus souvent considérés comme des hamartomes et non comme des tumeurs [Ref : Q8].
- Angiomatoses : lésions vasculaires multiples (ex : maladie de von Hippel-Lindau).

1. Tumeurs Bénignes : Musculaire, Cartilagineux, Osseux

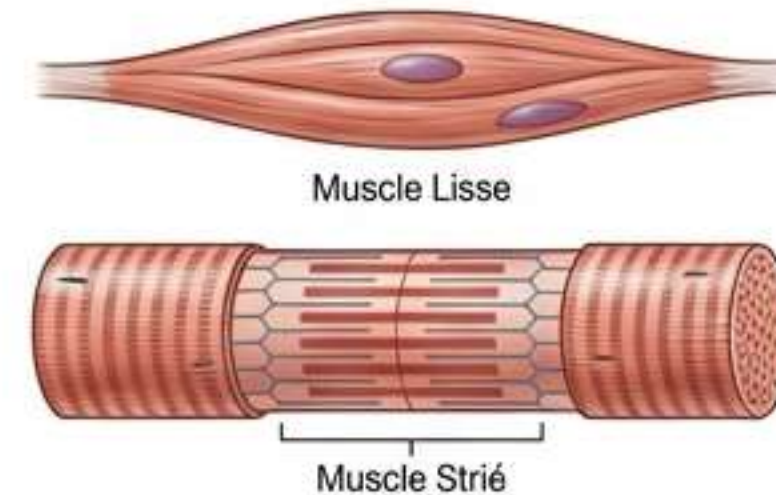
D/ Les Myomes (Tumeurs Musculaires)

Léiomyomes :



- Tumeur bénigne du muscle lisse [Ref: Q13].
- Fréquentes, bien circonscrites, parfois volumineuses.
- Siège : Utérus (improprement « fibrome »), tube digestif, derme.

Rhabdomyomes :



- Tumeur bénigne du muscle strié [Ref: Q3].
- Exceptionnelles (ex : rhabdomyome cardiaque de la sclérose tubéreuse de Bourneville).

E/ Les Chondromes

- Tumeur bénigne faite de tissu cartilagineux bien différencié [Ref : Q11].
- Lésions nodulaires.
- Siège : surtout petits os des mains et des pieds.



- Maladie de Ollier = chondromatose (multiples chondromes).

F/ Les Ostéomes

- Lésions rares, os mature.
- Siège : essentiellement os de la face.
- Nature tumorale discutée.



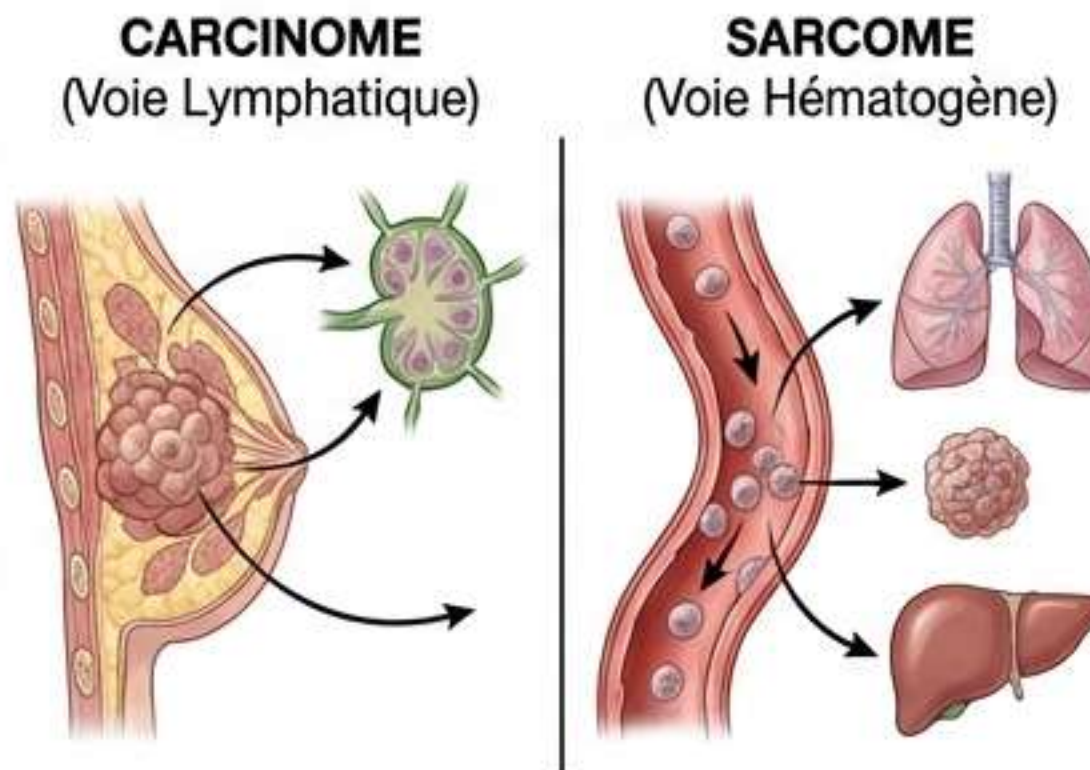
2. Les Tumeurs Malignes Conjonctives : Sarcomes

Définition & Classification

- Les **sarcomes** sont des **proliférations malignes** dont les **cellules ressemblent à celles des tissus conjonctifs** [Ref: Q1].
- Classification OMS 2020 : basée sur le **type de tissu reproduit** par la tumeur et non pas l'histogenèse.

Caractères Généraux & Évolution

- Beaucoup plus rares que les carcinomes.
- Évolution spontanée généralement rapidement défavorable.
- Extension loco-régionale rapide et fréquence des métastases hématogènes [Ref: Q14].
- Pronostic souvent sombre [Ref: Q7].



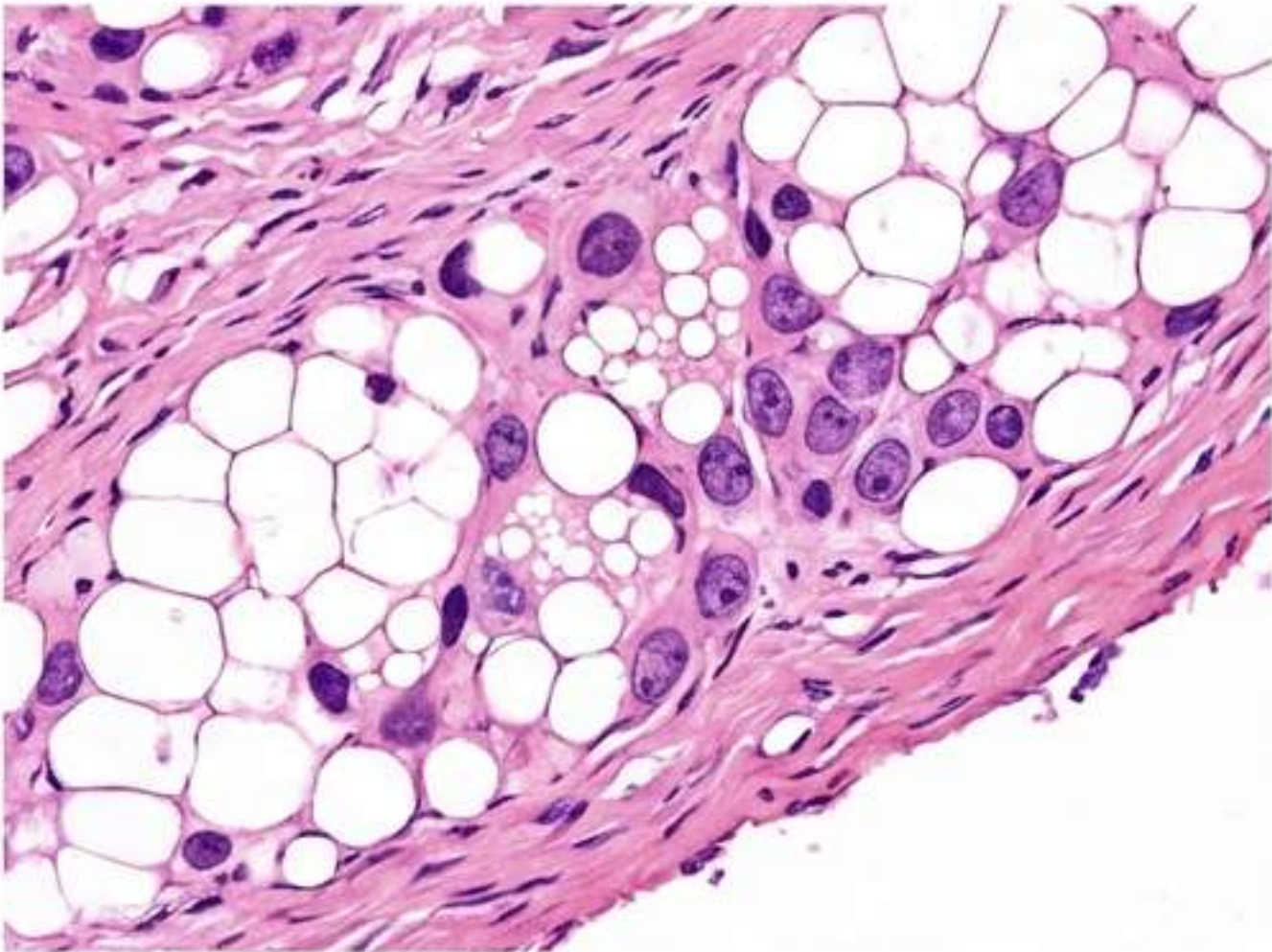
Macroscopie & Microscopie

- **Macro** : Tissu blanchâtre, consistance molle « encéphaloïde » (infiltrant) OU masse ferme polycyclique.
- **Micro** : Grading histopathologique basé sur 3 critères :
 1. Différenciation
 2. Nombre de mitoses
 3. Présence ou non de nécrose.

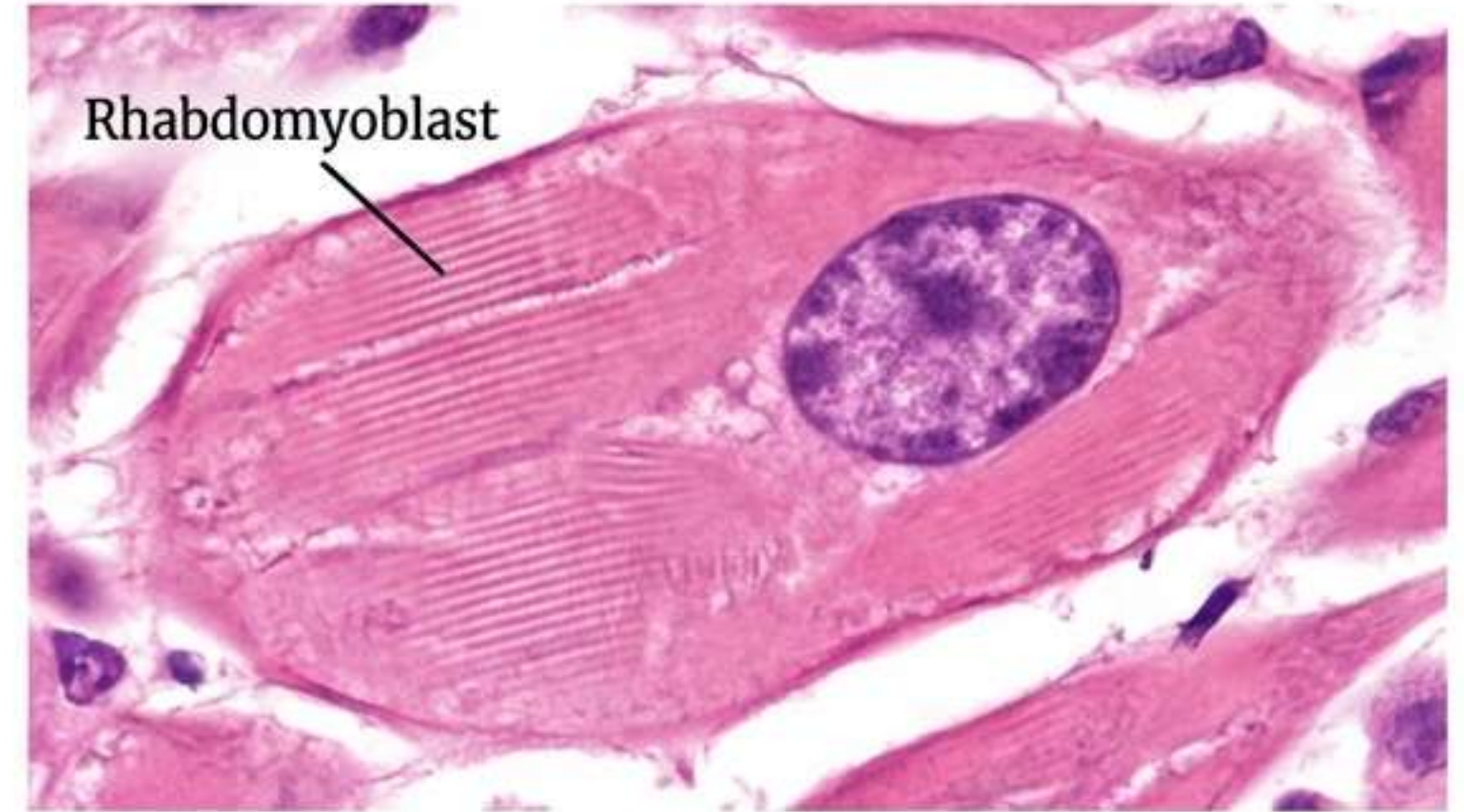
I- Sarcomes des Tissus Mous (1/2)

1. Liposarcomes

- **Développés à partir du tissu adipeux [Ref: Q15].**
- **Ubiquitaires** (fréquence : membres, espace rétropéritonéal).
- **Histologie** : de bien différencié (proche lipome) à peu différencié (lipoblastes).
- **Évolution** : Récidives locales et métastases.



2. Rhabdomyosarcomes



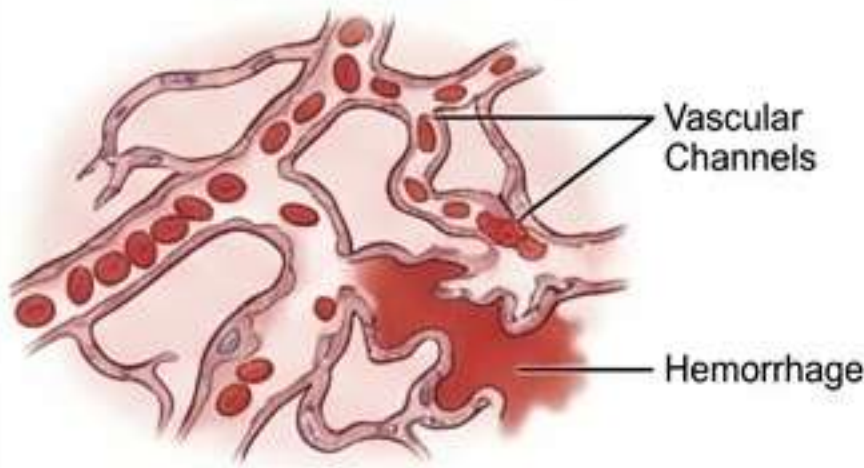
- **Tumeur maligne du muscle strié [Ref: Q10].**
- **Forme Adulte** : Se développe dans le muscle strié.
 - Prolifération fusiforme avec différenciation musculaire (double striation).
 - Évolution courte, métastases précoces.
- **Forme Embryonnaire (Enfant)** :
 - Ubiquitaire (en dehors des muscles striés).
 - Types histologiques : botryoïde, alvéolaire, embryonnaire.

I- Sarcomes des Tissus Mous (2/2)

3. Léiomyosarcomes

- Tumeur maligne du muscle lisse [Ref: Q5].
- Localisations fréquentes : derme, utérus, tube digestif.
- Histologie : Prolifération fasciculée de cellules fusiformes à différenciation musculaire lisse.

Angiosarcoma Schematic



4. Angiosarcomes

- Tumeur maligne de l'endothélium vasculaire [Ref: Q12].
- Aspects morphologiques très variés.
- Évolution grevée d'hémorragies massives.
- Sarcome de Kaposi = forme d'angiosarcome observée fréquemment au cours du SIDA.

5. Fibrosarcomes

- Prolifération maligne de fibroblastes [Ref: Q9].
- Histologie : Tumeur fasciculée, cellules fusiformes, fibres collagènes.
- Évolution : récurrences locales et métastases hématogènes.
- *Diagnostic différentiel* : attention aux proliférations proches mais bénignes.

II. Sarcomes des Tissus Squelettiques

1. Ostéosarcomes (Sarcomes ostéogéniques)



- Tumeur maligne primitive la plus fréquente de l'os [Ref: Q6].
- **Siège** : Métaphysaire (fémur, tibia, humérus, maxillaires).
- **Extension** : Détruit la corticale, dépasse le périoste (aspect radio « feu d'herbe »).
- **Histologie** : Prolifération fusiforme + foyers d'ostéogenèse tumorale.
- **Évolution** : Rapide, fractures spontanées, métastases (poumon).

2. Chondrosarcomes



- Tumeur du sujet adulte.
- **Siège** : Os plats (côtes, ceintures) ou métaphyse os longs.
- **Macroscopie** : Aspect lobulé, nacré, bleuâtre.
- **Microscopie** : Tissu cartilagineux plus ou moins élaboré.
- **Note** : Diagnostic de malignité difficile dans les formes bien différenciées.

Tumeurs des Tissus Hémolymphatiques (1/2)

Leucémies & Syndromes Lymphoprolifératifs

Diagramme : Leucémie - Moelle Osseuse et Sang Périphérique

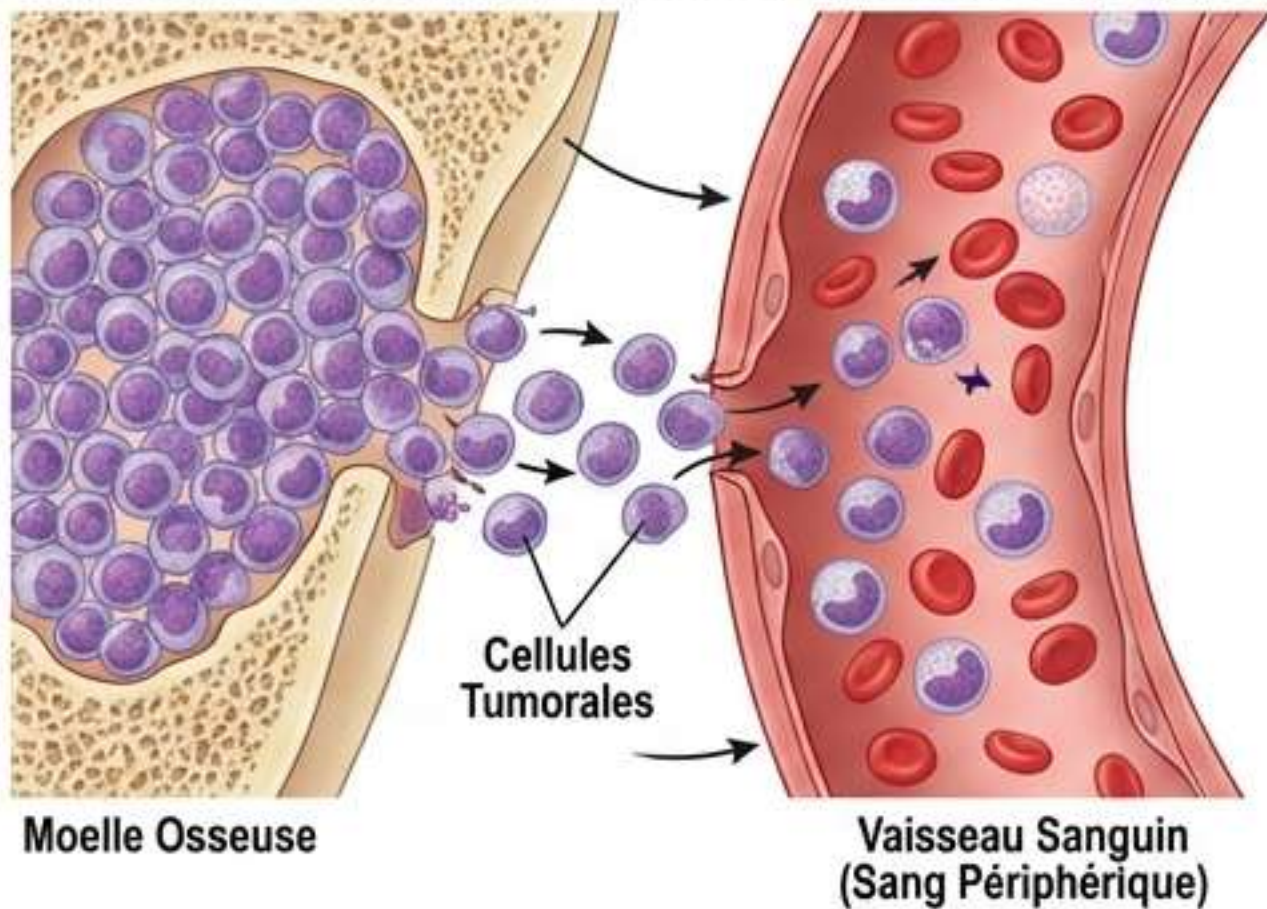


Diagramme : Leucémie - Moelle Osseuse et Sang Périphérique

- **Leucémies aiguës lymphoïdes :** Enfant et adulte jeune.
- **Leucémies lymphoïdes chroniques (LLC) :** Envahissement sanguin et médullaire par cellules lymphoïdes périphériques (LLC B ou T).
- **Autres syndromes :**
 - **Maladie de Waldenström (pic monoclonal IgM).**
 - **Maladie des chaînes lourdes.**
 - **Leucémie à tricholeucocytes.**

Myélome

- **Tumeur plasmocytaire de localisation osseuse.**
- S'accompagne souvent d'un pic monoclonal sérique (IgA, IgG).

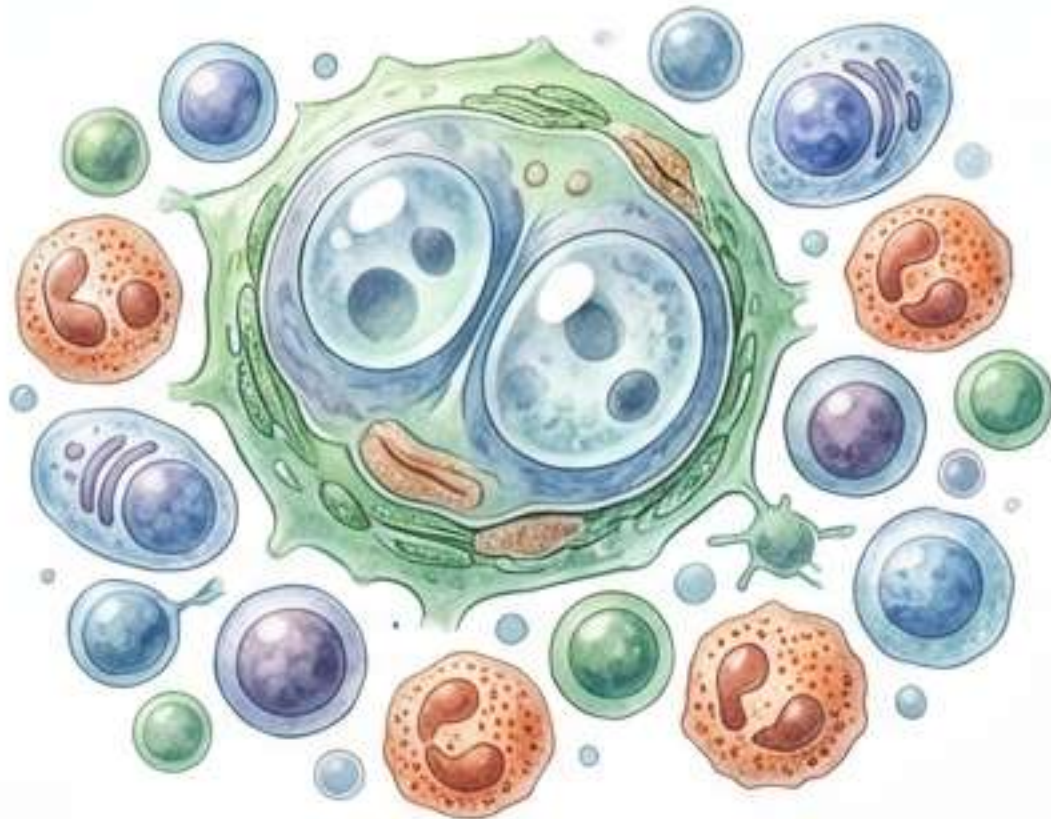
Tumeurs des Tissus Hémolymphatiques (2/2) : Les Lymphomes

Les lymphomes malins sont des tumeurs lymphoïdes **solides**.

Lymphomes Malins Non Hodgkiniens

- **Développement** : Tout territoire lymphoïde, muqueuses, thyroïde, glandes salivaires.
- **Classification** : Complexe (critères cytologiques, architecturaux, phénotypiques, cytogénétiques).
- Proliférations tumorales lymphoïdes B et T.

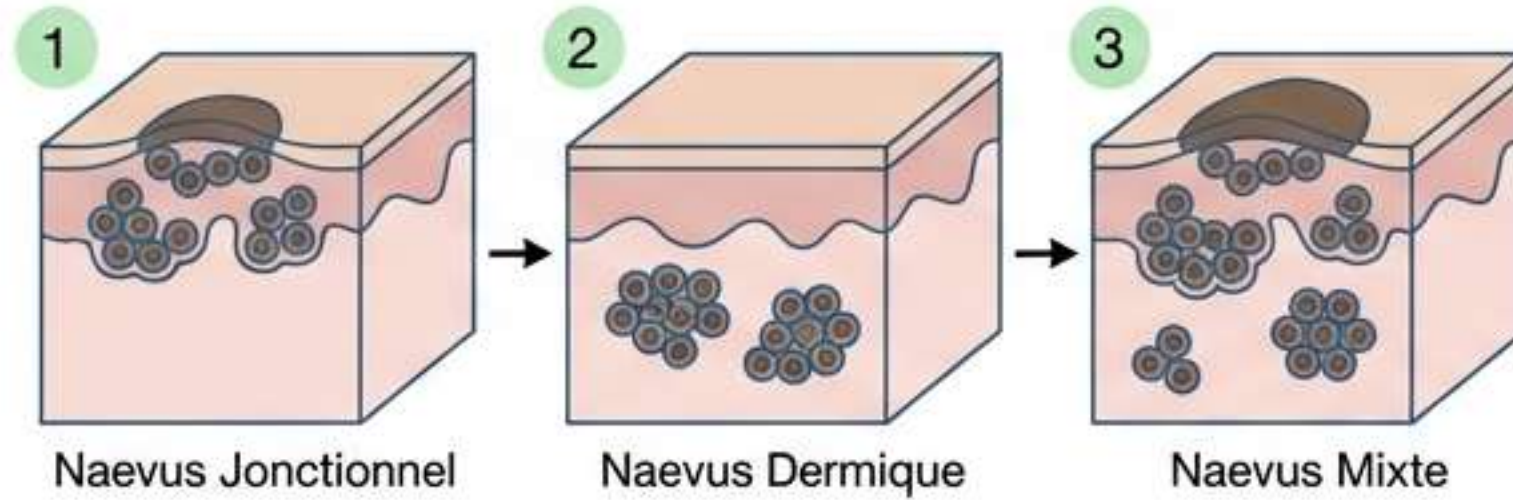
Lymphomes Malins Hodgkiniens (Maladie de Hodgkin)



- Prolifération cellulaire polymorphe.
- **Élément clé** : **Cellules de Sternberg (pathognomoniques)**.
- **Contexte cellulaire** : cellules non tumorales (lymphocytes, plasmocytes, éosinophiles).
- **Classification utilisée** : Lukes-Rye (4 types histologiques).

Les Tumeurs Mélaniques

Naevus Naevo-cellulaire (Bénin)



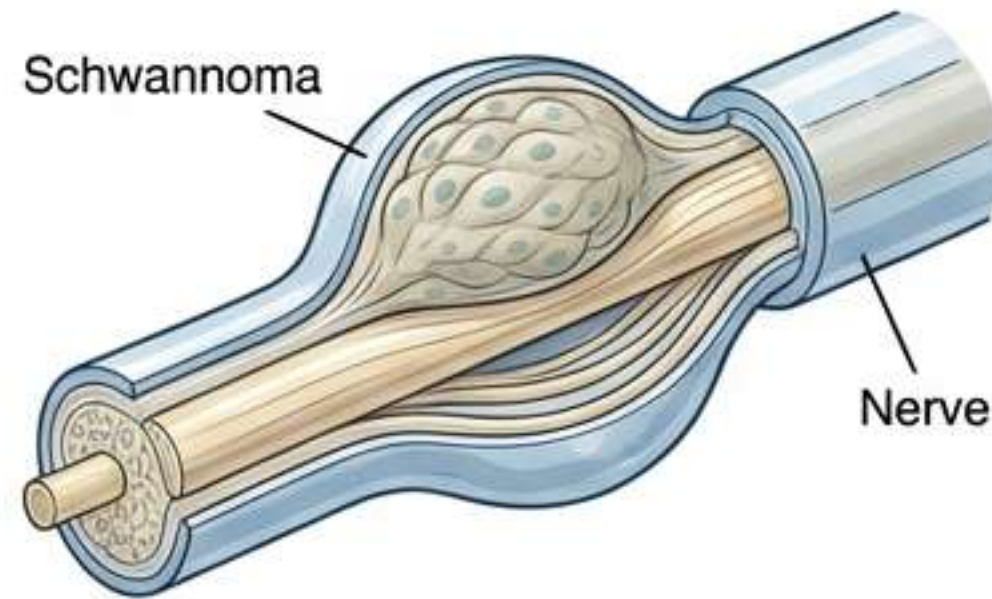
- Prolifération de cellules naeviques en amas (« thèques »).
- **Naevus Junctionnel** : Thèques à la base de l'épiderme.
- **Naevus Dermique** : Thèques dans le derme.
- **Naevus Mixte** : Aspects des deux.

Mélanome (Malin)

- Pronostic péjoratif, fréquence en augmentation.
- Facteur de risque : Exposition solaire enfance/adolescence.
- **Évolution en 2 stades** :
 1. Extension « horizontale » (intra-épidermique).
 2. Extension « verticale » (pénétration dermique -> métastases).

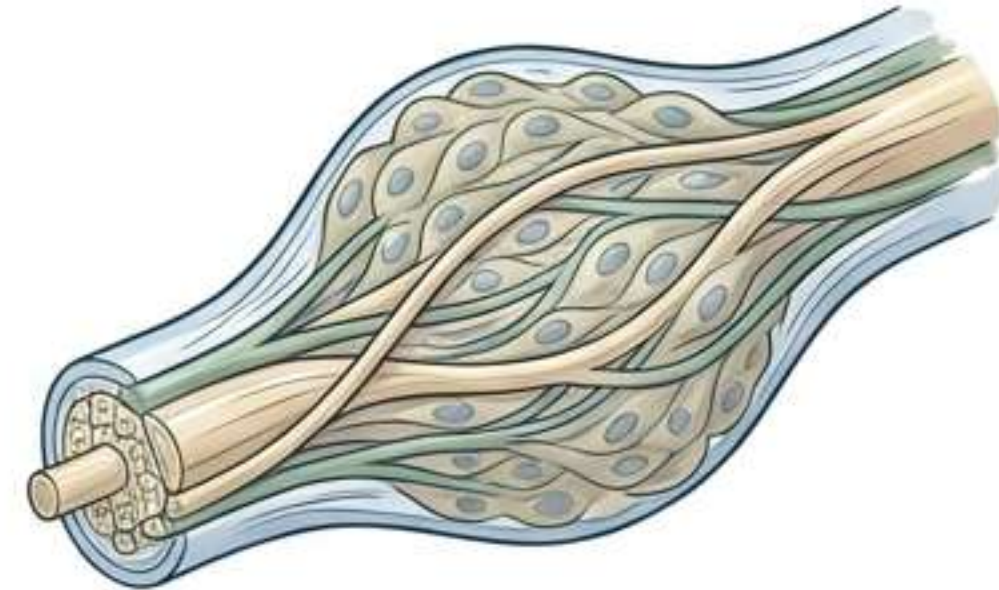
Les Tumeurs du Système Nerveux

Neurinomes ou Schwannomes



- Prolifération des **cellules de Schwann** de la gaine des nerfs.
- Survenant surtout chez l'adulte d'âge moyen.
- Tumeurs encapsulées, appendues à un nerf.
- Bon pronostic après exérèse.

Neurofibromes



- Prolifération **mixte** : cellules de Schwann + cellules fibroblastiques + fibres conjonctives.
- Peuvent être multiples.
- Cadre des **neurofibromatoses** (maladie génétique).

Synthèse & Révision Rapide

